

Sześć obszarów *pełnego planu*

Plan recovery to nie sam lek ani sama terapia. To zintegrowane podejście: leki + terapia + rehabilitacja + społeczność + sens + zdrowie fizyczne. Każdy obszar ma znaczenie.

CZAS: 15 min · przegląd całości · Po stabilizacji · z psychiatrą lub terapeutą

ŹRÓDŁO: Anthony (1993); NICE (2014); Wykes (2011); Bond (2008); Morrison (2017)

JAK UŻYWAĆ

Przejrzyj **sześć obszarów** pełnego planu leczenia psychozy (sekcje 1–6). Zaznacz, **które z nich masz już zaopiekowane**, a **które wymagają działania**. To karta przeglądowa — zabierz na wizytę.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Anthony (1993): pełne *recovery* w psychozie to integracja wielu elementów — żaden z nich w pojedynkę nie wystarcza. NICE (2014) CG178: kompleksowa opieka obejmuje *farmakoterapię, terapię psychologiczną, interwencję rodzinną, rehabilitację zawodową i społeczną, zdrowie fizyczne*. Mimo silnych rekomendacji — w praktyce wielu pacjentów otrzymuje *tylko* farmakoterapię, a inne obszary są pomijane. Plan recovery pomaga zauważyć **luki** i zaplanować, czym się zająć w pierwszej kolejności. *Nie wszystko naraz* — krok po kroku, w tempie, które jest dla Ciebie wykonalne.

01 Fundament · Leki + plan nawrotów

ANTYPSYCHOTYK CODZIENNIE

Minimum 1–2 lata po pierwszym epizodzie (NICE 2014). Odstawienie zwiększa ryzyko nawrotu **5×** (Robinson 1999). O wszelkich zmianach decyduje psychiatra.

REGULARNY KONTAKT PSYCHIATRYCZNY

Wizyty co 1–3 miesiące (po stabilizacji). *Monitoring* objawów, dawki, działań niepożądanych. Nie odwołuj — to filar planu.

PLAN NAWROTÓW — „TRZY POZIOMY”

Wczesne sygnały (sen, niepokój, izolacja) + plan dla 3 poziomów (zielony/żółty/czerwony) + telefony kryzysowe. Birchwood (1989): wczesne wykrycie redukuje hospitalizację o 50%.

02 Terapia · CBTp + interwencja rodzinna

CBTP

16–26 sesji. Formułacja, praca z konkretnymi objawami, łagodne eksperymenty. Cel: redukcja dystresu, nie eliminacja objawów (Morrison 2017).

INTERWENCJA RODZINNA

10–20 sesji. Psychoedukacja, redukcja EE, komunikacja, plan kryzysowy. Pharoah Cochrane (2010): NNT = 7 dla zapobiegania nawrotom.

03 Rehabilitacja · CRT + IPS

CRT — TRENING POZNAWCZY

Cognitive Remediation Therapy. 2–3×/tydz., 3–6 mies. Wykes (2011): $d = 0,45$ dla funkcji poznawczych. Najlepiej zintegrowany z pracą.

IPS — WSPIERANE ZATRUDNIENIE

„Place then train”. Bond (2008): 61% sukces vs 23% tradycyjna rehabilitacja. Praca = sens, struktura, dochód, kontakty.

04 Społeczność • Grupy wsparcia + peer

PEER SUPPORT • GRUPY WSPARCIA

Sieć Słyszących Głosy Polska, asystenci zdrowienia, online grupy. Minimum **1 regularna** aktywność społeczna w tygodniu.

BLISCY • RODZINA

Wsparcie 1–2 zaufanych osób, które wiedzą o Twojej sytuacji. Nie musisz mówić wszystkim — wystarczy mała sieć bezpieczeństwa.

05 Sens • Wartości i cele

WARTOŚCI (ACT)

„Co chcę z moim życiem?” Nie cele, lecz kierunki: relacje, twórczość, służba, wiedza, natura. Wartości nie kończą się — można je realizować codziennie.

CELE KONKRETNE

Tygodniowe (małe, wykonalne) + roczne (kierunkowe). SMART: specyficzne, mierzalne, osiągalne, terminowe.

06 Zdrowie fizyczne • Ruch + sen + brak używek

RUCH • 20 MIN/DZIEŃ

Firth (2015): ćwiczenia poprawiają też *objawy negatywne* i funkcje poznawcze. Antypsychotyk + siedzący tryb = ryzyko metaboliczne.

SEN • 7–9 H

Regularna pora, ciemny pokój, bez ekranów na godzinę przed. Brak snu jest jednym z najczęstszych wczesnych sygnałów nawrotu.

BEZ UŻYWEK

THC, amfetamina, alkohol — silnie nasilają objawy i ryzyko nawrotu. Wsparcie w rzucaniu palenia (70% pacjentów pali).

07 Moje luki i priorytet

CO MAM JUŻ ZAOPIEKOWANE

— które z 6 obszarów działa

PIERWSZY PRIORYTET DO DZIAŁANIA

— co zacznę w tym miesiącu

Klucz: recovery to **nie brak objawów** — to *pełnia życia mimo objawów*. Praca, relacje, sens, zdrowie fizyczne — to są cele. Anthony (1993) zmienił paradygmat psychiatrii: zamiast pytać „czy pacjent jest bezobjawowy?”, zaczął pytać „czy pacjent żyje życiem, które dla niego ma wartość?”. Sześć obszarów nie musi być realizowane *jednocześnie* — wybierz **jedno**, w którym jest największa luka, i działaj. Plan żyje wraz z Tobą — aktualizuj go regularnie. Część obszarów zaopiekuje psychiatra (fundament, *monitoring* zdrowia), część terapeuta (CBTp), część Ty sam/sama (sens, społeczność, zdrowie). To **zespół**.